



Résumé : RPP SFAR sur l'optimisation hémodynamique périopératoire en pédiatrie — 9 avis d'experts sur 4 champs : cibles de pression artérielle par tranche d'âge, monitoring du volume d'éjection systolique/indices dynamiques, indices de perfusion tissulaire, expansion volémique et vasoconstricteurs. Transfusion exclue du champ.

AE

AE = Avis d'experts — méthode GRADE grid ($\geq 70\%$ d'opinions favorables, $< 20\%$ contraires). **Les 9 avis d'experts ont tous recueilli un accord fort**, sans exception ; document entièrement non gradé (aucun GRADE 1+/1-/2+/2- imprimé — la méthode GRADE n'a servi qu'à l'analyse bibliographique en amont). Une « absence de recommandation » (littérature insuffisante, 4 cas) est distincte d'une recommandation négative (« il ne faut pas faire », absente de ce document) — distinction explicite du texte source.

Champ 1 — Optimisation périopératoire de la pression artérielle

Réf.	Avis d'experts	Cotation
R1.1.1	Chez l'enfant anesthésié < 6 mois, maintenir une PA moyenne peropératoire > 35 mmHg pour limiter les complications cérébrales.	AE
R1.1.2	Chez l'enfant anesthésié de 6 mois à 2 ans, maintenir une PA moyenne peropératoire > 43 mmHg pour limiter les complications cérébrales.	AE
R1.1.3	Chez l'enfant anesthésié de 2 à 10 ans, maintenir une PA moyenne peropératoire $> [1,5 \times \text{âge (ans)} + 40]$ mmHg pour limiter la morbidité postopératoire.	AE

Champ 2 — VES et indices dynamiques pour l'expansion volémique

Absence de recommandation (littérature insuffisante — nécessite une évaluation individualisée bénéfice/risque) : intérêt du monitoring du volume d'éjection systolique pour optimiser l'hémodynamique et diminuer la morbi-mortalité, pour la population pédiatrique générale.

Absence de recommandation (littérature insuffisante — nécessite une évaluation individualisée bénéfice/risque) : intérêt des indices dynamiques seuls pour optimiser l'expansion volémique, pour la population pédiatrique générale.

Réf.	Avis d'experts	Cotation
R2.1	Utiliser le Doppler œsophagien pour optimiser l'hémodynamique peropératoire du patient pédiatrique à risque élevé ou très élevé, si la tête est accessible et en l'absence d'échocardiographie peropératoire.	AE

Champ 3 — Indices de perfusion tissulaire

Réf.	Avis d'experts	Cotation
R3.1	La surveillance de la lactatémie, en cas de circonstances évocatrices d'hypoxie tissulaire (bas débit peropératoire), peut être utile pour estimer la sévérité de la souffrance cellulaire et son évolution.	AE

Absence de recommandation (littérature insuffisante — nécessite une évaluation individualisée bénéfice/risque) : intérêt de la différence veino-artérielle en CO₂ (DIVA-CO₂) et de la saturation veineuse en oxygène (ScvO₂).

Réf.	Avis d'experts	Cotation
R3.2	Utiliser un monitoring de la perfusion/oxygénation tissulaire cérébrale chez l'enfant < 1 an opéré d'une chirurgie majeure ou à risque cérébral particulier, pour optimiser l'hémodynamique peropératoire.	AE

Champ 4 — Expansion volémique, vasoconstricteurs, inotropes

Réf.	Avis d'experts	Cotation
R4.1.1	Privilégier l'expansion volémique initiale par un soluté cristalloïde balancé, limité dans le temps, pour maintenir l'homéostasie biologique et circulatoire.	AE



Réf.	Avis d'experts	Cotation
R4.1.2	Chez le nouveau-né et le jeune nourrisson, utiliser l'albumine à 4-5 % après l'expansion volémique initiale cristalloïde, pour limiter le volume d'expansion volémique.	AE
R4.2	En cas d'hypotension artérielle peropératoire persistante malgré une expansion volémique adaptée, utiliser un vasoconstricteur avec des doses rapportées au poids majorées par rapport à l'adulte.	AE

Absence de recommandation (littérature insuffisante — nécessite une évaluation individualisée bénéfice/risque) : quel vasoconstricteur utiliser pour la population pédiatrique.

Sources et avertissement

SFAR, « Optimisation hémodynamique périopératoire – Pédiatrie », RPP, mars 2024. Méthode GRADE (analyse de la littérature, PRISMA) + cotation GRADE grid.
Références bibliographiques citées dans le texte intégral (non reproduites ici) ; composition nominative du groupe d'experts (non reproduite).

Avertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 9 avis d'experts et les 4 cas d'absence de recommandation du texte source, mais condense l'argumentaire de chaque item et omet la composition nominative du groupe d'experts. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR.